长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

医药行业研究框架浅析

长江证券研究所 医药研究小组

2022年4月28日

Changjiang Securities

汇聚财智 共享成长

Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth

•证券研究报告•		
评级	看好	维持

分析师及联系人

分析师　伍云飞

SAC执业证书编号：S0490521060001

电话：15618202865

电邮：wuyf@cjsc.com

分析师　方程嫣

SAC执业证书编号：S0490520080025

电话：18817337266

电邮：fangcy@cjsc.com

分析师　芦湖

SAC执业证书编号：S0490520090002

电话：13901712886

电邮：luhu@cjsc.com

联系人　单林

电话：13816777271

电邮：shanlin@cjsc.com

联系人　郭心驰

电话：18817868960

电邮：guoxc@cjsc.com

目录

01 医药产业链分析

02 行业政策&管理规范

03 子行业投资框架

04 从龙头成长看行业变革

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

01

医药产业链分析

汇聚财智　共享成长

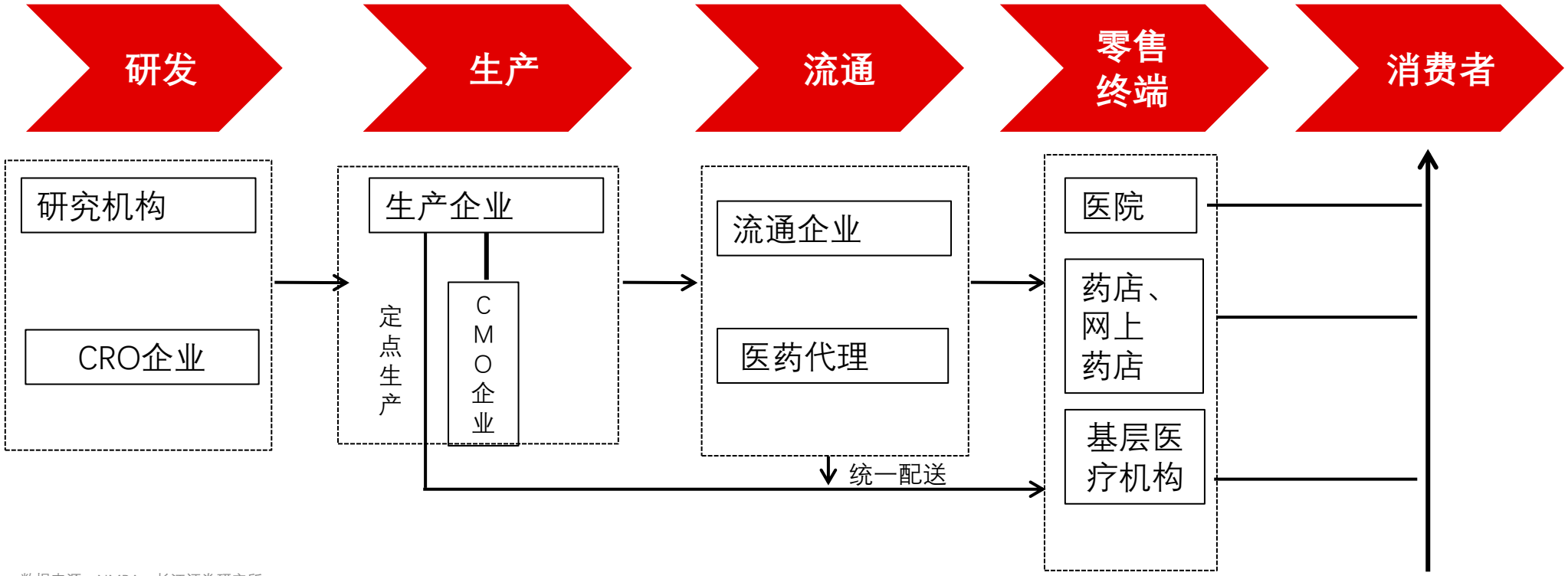
Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth

01 医药行业产业链分布

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

中国医药行业产业链复杂，历经研发、生产、流通、零售等环节最终到达消费者手中

图：中国医药产业链上下游示意图



数据来源：NMPA，长江证券研究所

01 需求端分析

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

人口老龄化：随着人口结构的变化，国内整体医疗需求将会快速积增

- 未来5-10年，国内60岁以上人口占比将有不小的提升空间；
- 国内住院人群中60岁以上占比最高，国内医疗需求还会在未来很长一段时间内不断出现高峰。

就医意识和水平提高：我国城镇率正在不断提升，将拉升居民收入，进而增加对医疗消费需求

- 城镇人口比率从2004年的41.7%上升到2019年的60.6%。

医疗支出增加：我国卫生总费用支出逐年增加，但是跟国外发达国家相比，资源仍然相对不足

- 以日本为例，中国人口体量相当于10个日本，医药市场规模日本的1.65倍，医疗支出GDP占比相当于对方约20年前的水平。

慢性病和癌症是主要威胁：中国的慢性病患病率呈现上升趋势，癌症的患病率和死亡率逐年升高。

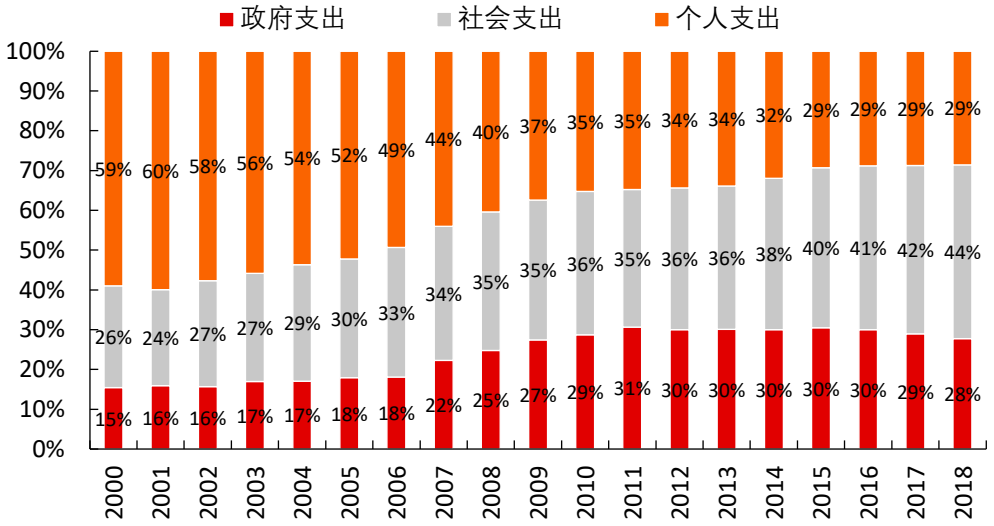
- 以糖尿病的患病率为例，2014年全国18岁及以上成人，糖尿病患病率为11.2%，而在2002年患病率为2.6%。

01 国内医疗卫生费用主要由政府和社会承担

国内支付主体是政府和社会，美国依赖于个人保险和商保。不论中美，个人卫生支出占比都已经到降到30%以下。

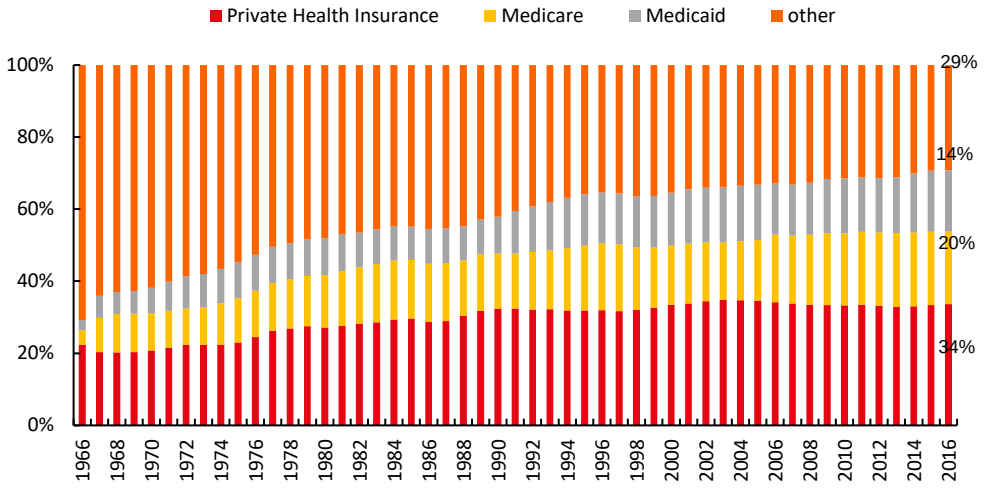
中国的社会卫生支出主体 — **国家医保基金。**

图：中国医疗卫生费用支出结构



数据来源：Wind, 长江证券研究所

图：美国医疗卫生费用支出结构



数据来源：Bloomberg, 长江证券研究所

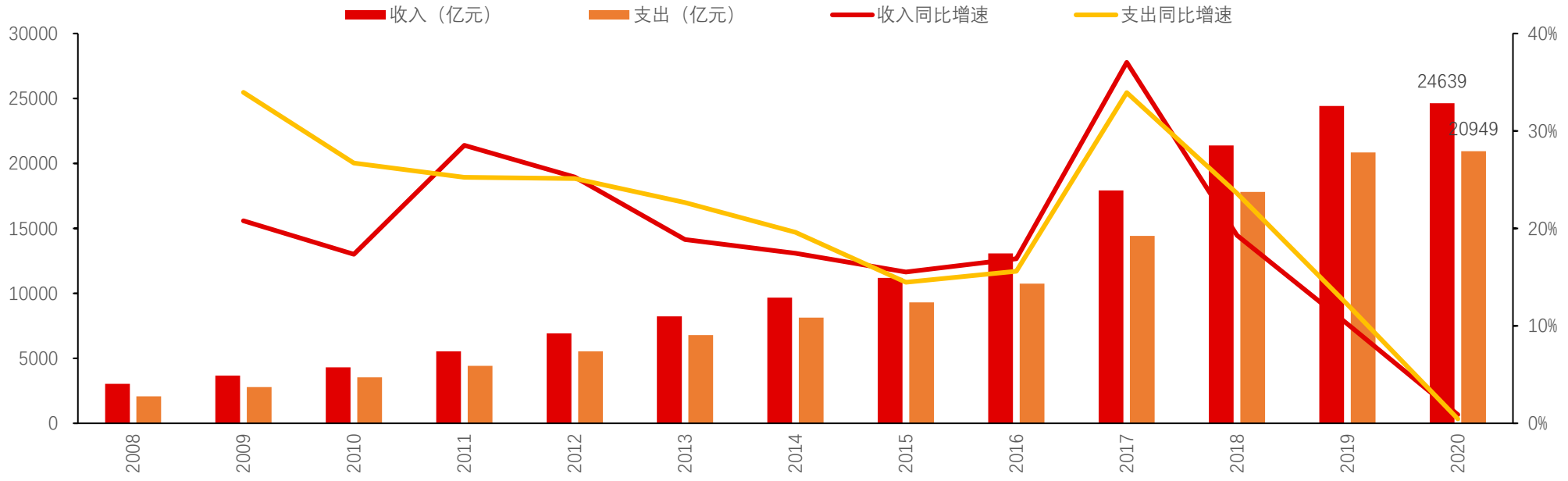
01 国家医保：基本实现全覆盖，支出增速较高

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

医保基金运行平稳，支出增速高于营收增速已是常态

- 筹资端没有新参保人员的增量贡献（国家医保已覆盖超95%人口）。

图：国家基本医疗保险基金历年收支情况（2008-2020年）



数据来源：国家医保局，《中国卫生统计年鉴》，长江证券研究所

01 国家医保控费的影响

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

加大医疗保障力度

- 大病保险：2015年底前覆盖所有城乡居民基本医保人群，从城乡居民基本医保基金中进行筹资，逐步提高支付比例，到2017年建立起比较完善的大病保险制度。
- 医保整合：整合城镇居民医保和新农合，建立统一的城乡居民医保，通过统一筹资政策、统一保障待遇、统一医保目录定点管理、基金管理，提高统筹层次、完善信息系统、支付方式和医疗服务监管。

降低费用，提升效率

- 付费方式：加强总额控制，探索按人头付费、按病种付费。
- 鼓励民营医疗：医疗服务价格实行市场调节，建立谈判机制，符合医保定点规定的，纳入社保定点服务范围，执行与公立医院相同的支付政策。

01 国家医保控费的影响

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

招标采购机制：

- 高值医用耗材必须通过省级集中采购平台进行阳光采购，保证质量的前提下鼓励采购国产。
- 药品招标趋于严格，**带量采购**逐渐成为主流。

付费机制：

- 实施总额控费，高端仿制药、国产高值耗材的进口替代率先体现。
- 医疗服务价格进行调整，普通耗材、检测试剂成为成本项。
- 单病种付费和简单DRGs有望普遍执行，进而逐步向全面的DRGs演变，结合总额控制，收缩开支。

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

02

行业政策&管理规范

汇聚财智　共享成长

Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth

02 制药行业监管部门和管理规范

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

医药有自己的行业管理规范和准入条件，从研发到生产到流通和销售都有一系列的监管和管理规范

图：制药行业从临床到上市流通的全流程管理规范

国家市场监督管理总局，卫健委，国家医保局，中医药管理局，发改委，科技部，商务部，知识产权局

加快新药审批和临床试验监管	加强药品生产质量监管	整顿流通渠道推动产业整合	分类管理，控制药占比
药物研究、临床实验 →	**生产** →	**流通** →	**医疗机构**
GLP药物非临床研究质量管理规范 GCP药物临床试验质量管理规范 **执行越来越严**	GMP药品生产质量管理规范 **新版更严，淘汰落后产能**	GSP药品经营质量管理规范 **提高行业集中度和规范**	GPP医疗机构制剂配制质量管理规范 **规范医院药品制剂配置**

数据来源：卫健委等政府网站，长江证券研究所

02 药品注册分类管理：“全球新”导向

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

表：新版化药注册分类准则

注册分类	分类说明	包含的情形
1	境内外均未上市的创新药	含有新的结构明确的具有生理或药理作用的分子或离子，且具有临床价值的原料药及其制剂
2	境内外均未上市的改良型新药	2.1 含有对已知活性成份成酯、成盐（包括含有氢键或配位键的盐），或者形成其他非共价键衍生物（如络合物、螯合物或包合物），或者改变其结晶水、结晶溶剂、晶型的原料药及其制剂。
		2.2 含有已知活性成份的新剂型（包括新的给药系统）和/或给药途径的制剂。
		2.3 含有已知活性成份的新复方制剂。
		2.4 含有已知活性成份的新适应症的制剂。
		2.5 含有已知活性成份的新用法用量和新规格的制剂。
3	仿制境外上市、境内未上市的药品	具有与参比制剂相同的活性成份、剂型、规格、适应症、给药途径和用法用量的制剂及其原料。
4	仿制境内上市的药品	具有与参比制剂相同的活性成份、剂型、规格、适应症、给药途径和用法用量的制剂及其原料。
5	境外上市的药品申请在境内上市	境外上市的原料或制剂申请在境内上市。

数据来源：CDE，长江证券研究所

02 药品专利保护

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

药品专利保护范围	产品发明	新/已知化合物、药物组合物、微生物及其代谢物、医疗器械
	方法发明	生产工艺、工作方法和用途发明（新适应症、增效组合物等）
	非发明专利	实用新型专利、外观设计专利

84年专利法 → 93年新专利法 → 2001年加入WTO

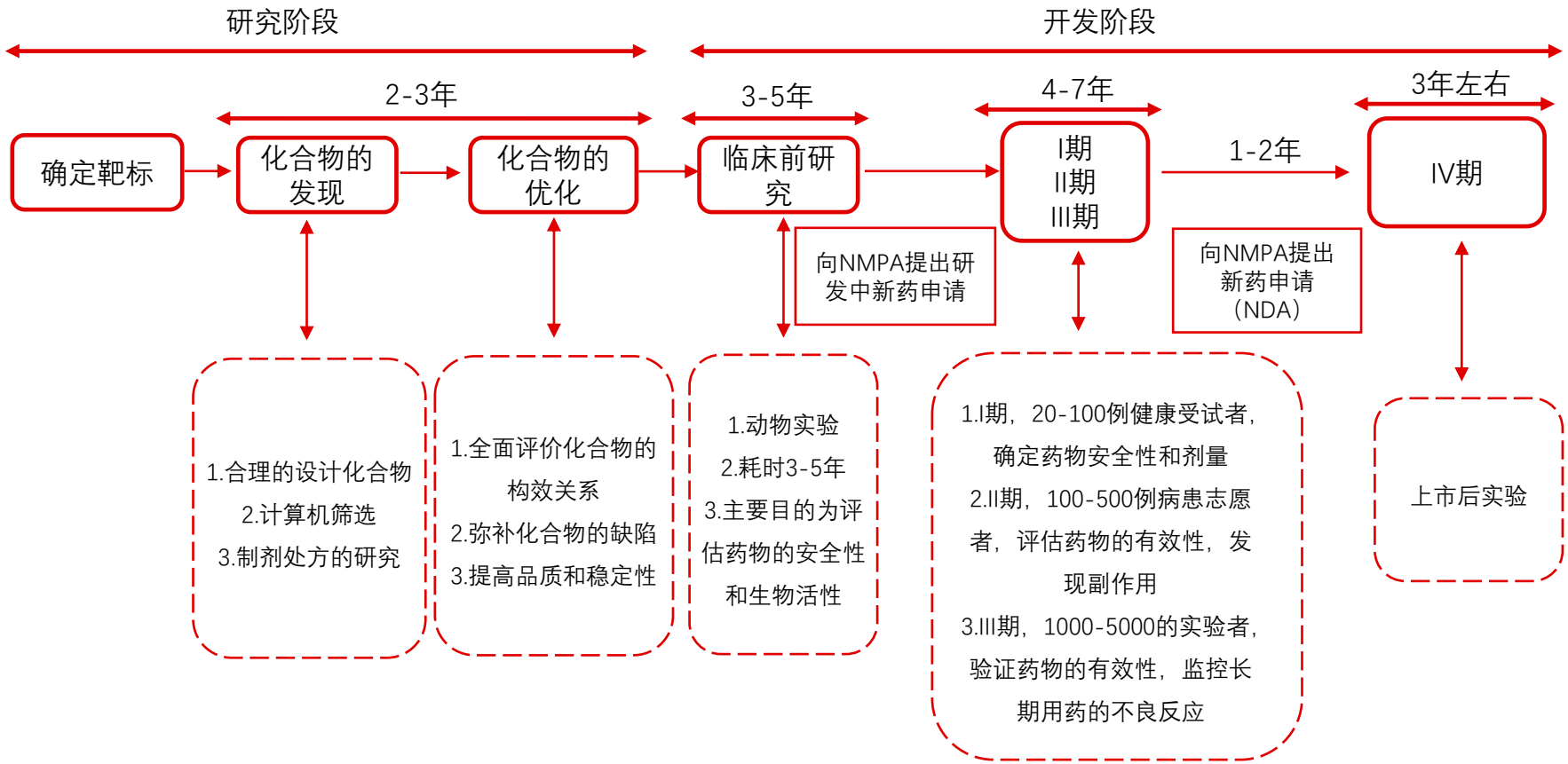
未定义化合物专利保护　　化合物专利保护　　Trips协议的全面接轨

→ 2008年专利法第三次修改 → 2015年专利法第四次修改征求意见

更全面保护专利权人　　更全面保护专利权人

数据来源：国家药品监督管理局，长江证券研究所

02 药物研发与审批 1/3：新药研发的一般流程



数据来源：国家药品监督管理局，长江证券研究所

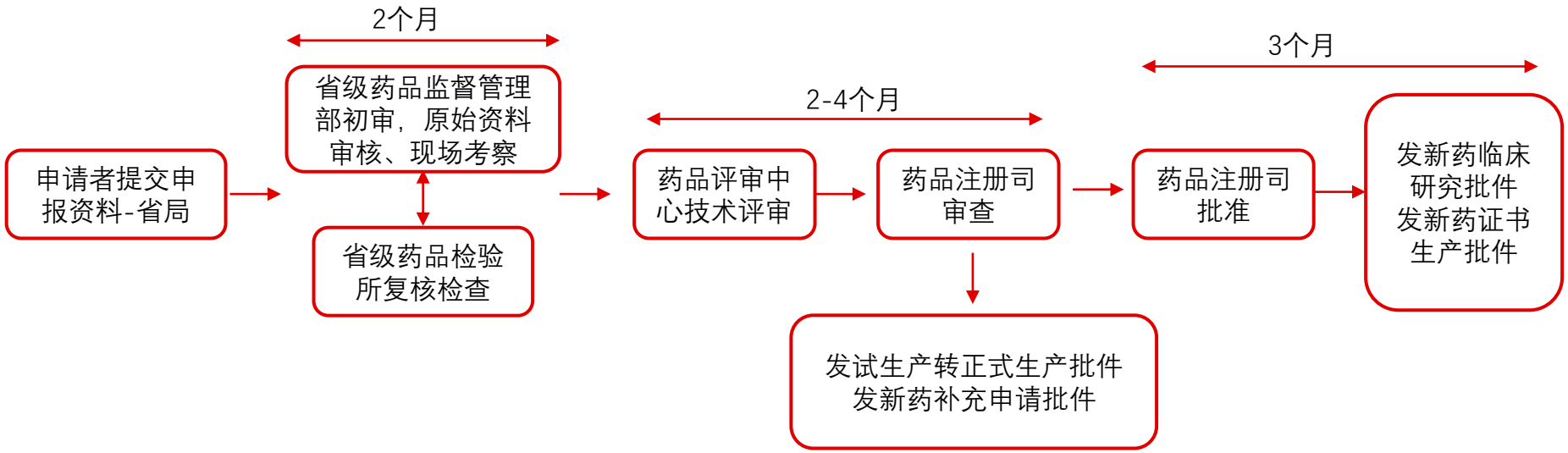
02 药物研发与审批 2/3：新药注册审批流程

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

提高药品审批标准：仿制药质量一致性评价；加快创新药的审批

（2015年8月18日，国务院，《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》）

图：我国新药注册审批流程



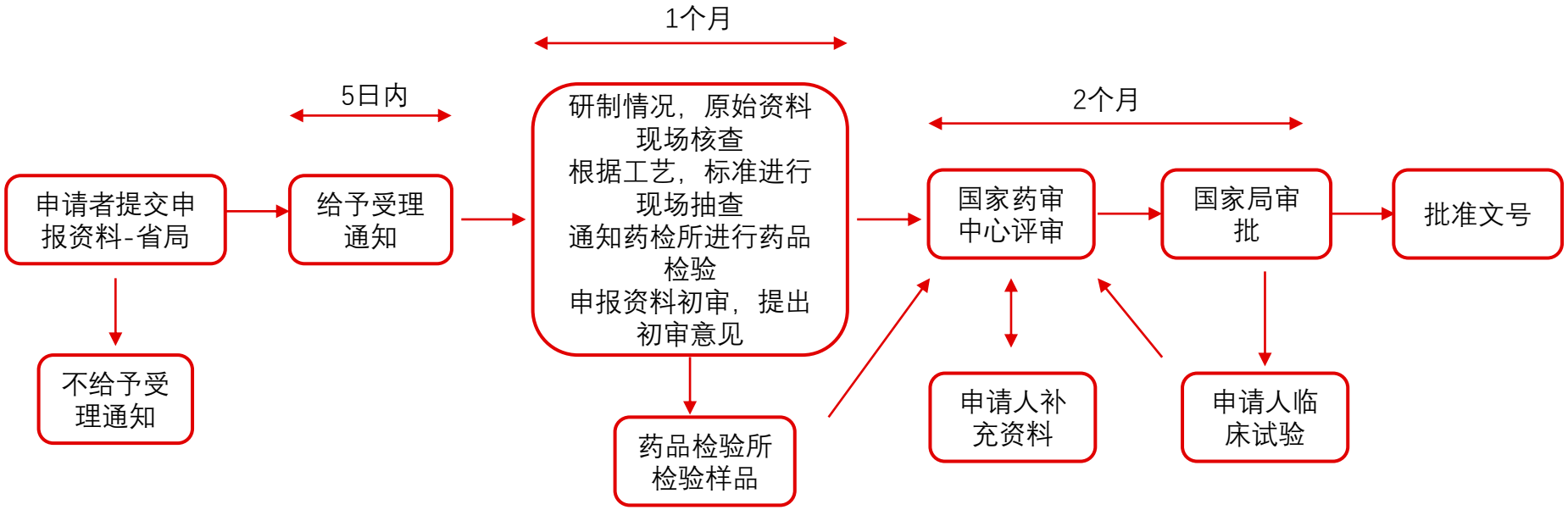
数据来源：国家药品监督管理局，长江证券研究所

02 药物研发与审批 3/3：仿制药注册审批流程

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

仿制药的注册审批流程加快

图：我国仿制药注册审批流程



数据来源：国家药品监督管理局，长江证券研究所

02 医药行业产业链分布

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

- 医保目录药品
  - 国家甲类、乙类（往往进入多数地区目录）
  - 各地区目录药品
  - 医保目录制定&调整；仿制药集中采购；创新药谈判；
- 非目录药品
  - 非医保报销范围；市场处于萎缩态势；
- 处方药
  - 必须凭医生处方购买；目前主要在医院及药店等线下终端销售，有网售放开趋势；不能进行广告宣传；
- 非处方药
  - 甲类
  - 乙类
  - 无需处方购买 可进行广告宣传

数据来源：NMPA，长江证券研究所

02 药品定价改革

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

取消绝大部分药品政府定价，定价向医保和市场转移

药品类型	定价原则
仿制药	根据社会平均成本与合理利润制定统一最高零售限价
专利药	根据企业个别成本定价
原研药	允许比仿制药价格高30-35%
同种药品不同剂型、规格	政府选代表剂型、规格定价，其他按照差价比价原则
县及县以上非营利医疗机构	以实际进购价为基础加15%

类型	2015年之前定价机制	改革之后的定价机制
医保目录中处方药	最高零售限价	医保支付标准
医保目录中非处方药、民族药和中药饮片	省级价格主管部门定价	医保支付标准
专利药	最高零售限价	议价
医保目录外的血液制品	最高零售限价	招标竞价/议价
麻醉药品、一类精神药品	出厂价和省级价格主管部门定价	暂实行最高出厂价和最高零售价格管理
按国家指令性计划生产并由国家统一收购的避孕药具和计划免疫药品	出厂价	招标竞价/议价
其他药品	市场定价	自主定价

数据来源：NMPA，长江证券研究所

02 国家医保局的成立开启了一个新的时代

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

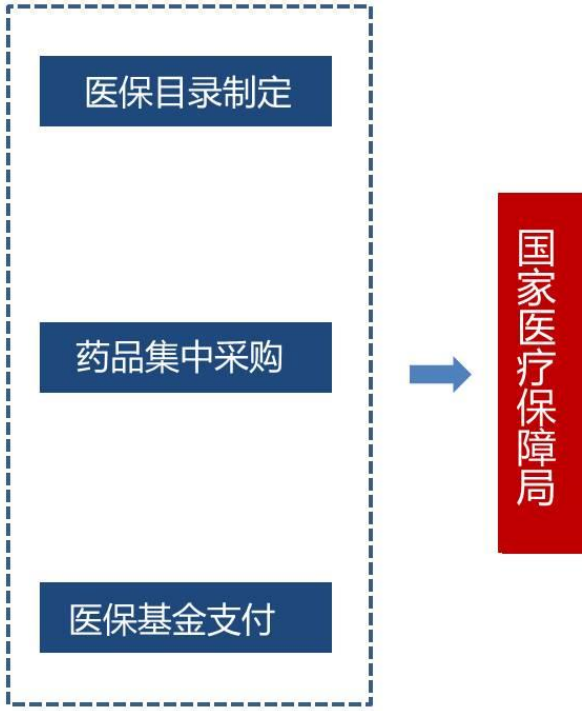
2018年6月1日，国家医保局成立。统筹3大社会医疗保险，具有定价、招标、支付、救助等职能。

图：国家医保局统筹管理社会医疗保险基金

- 医保目录动态调整，建立常态化、动态化医保目录准入机制
- 维护医保目录经济性，限定部分药品适用范围
- 完善医保定点协议管理，全面推开医保智能监控

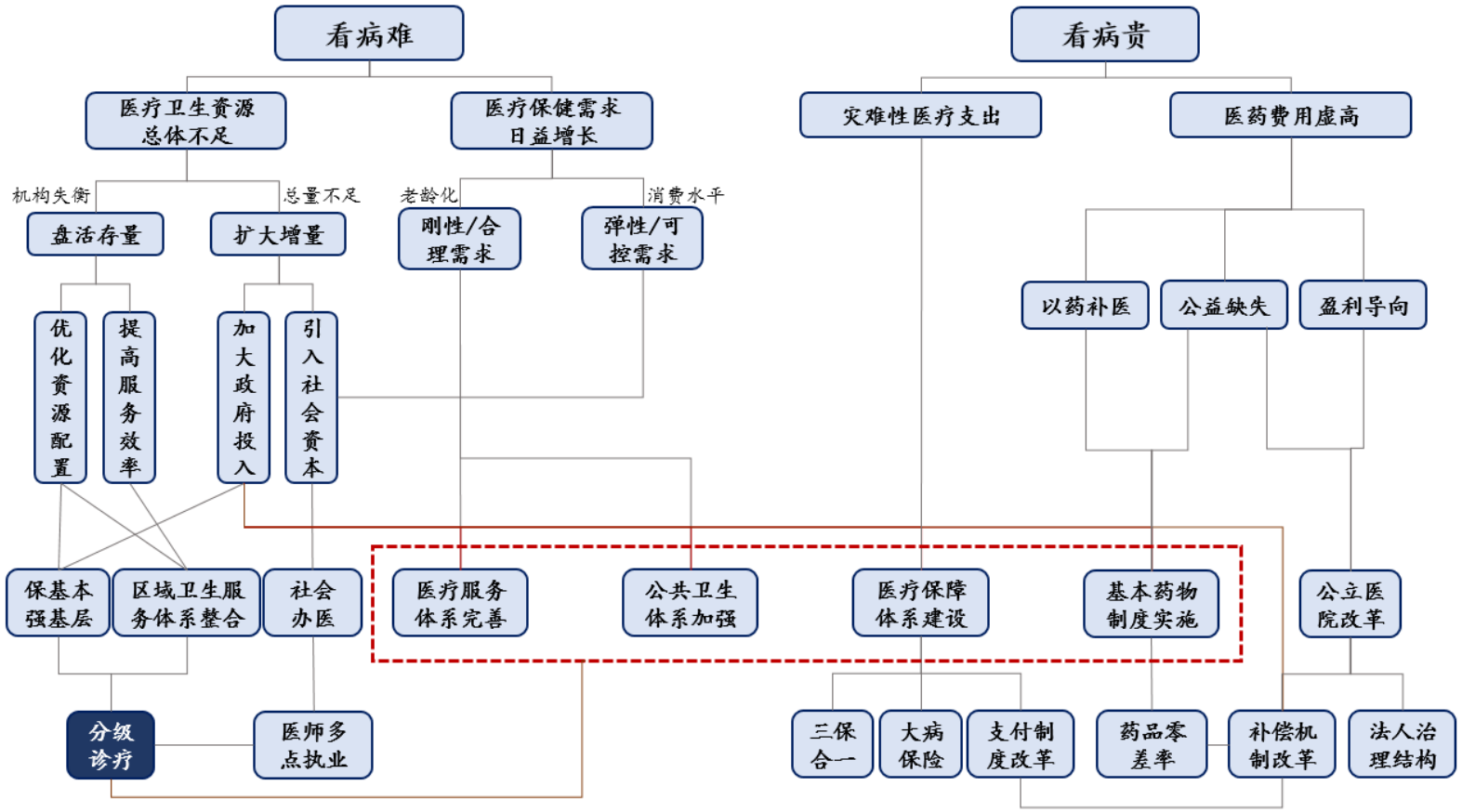
- 专项采购、价格谈判频率上升，范围加大
- 动态限价招标、谈判议价、联合体带量采购、鼓励医院二次议价
- 形成医保支付标准/医保支付参考价，按通用名定价
- 鼓励仿制药通过一致性评价后进口替代

- 探索多元复合式医保支付方式；
- 重点推行按病种付费，开展按DRGs付费试点，完善按人头付费、按病日付费等支付方式



数据来源：NMPA，长江证券研究所

02 卫生政策分析框架



数据来源：NMPA，长江证券研究所

02 社会资本办医方向

	介入方式	关键因素	未来趋势
专科连锁	低壁垒的介入：如体检，美容领域 高壁垒的介入：如妇产，口腔，眼科、辅助生殖等领域	品牌因素 技术壁垒 专科领域是否适应需求	短期资本介入为主，“跑马圈地“。预计未来连锁机构规模逐渐变大，资本并购速度加快
综合医院	新建医院 收购医院 参与公立医院改制	审批的流程长短 医院的盈利水平。 政策导向：不同地方社会资本参与公立医院改制政策不同 供应链管理	预计未来政策会进一步放开，社会资本新建综合医院或收购的规模会逐渐加大，但参与公立医院改制仍存在风险
康复养老	建立医疗养老社区	可复制性 大医院的依托 医保的覆盖程度	康复养老社区的数目会逐渐增多，以轻资产的模式居多。社区未来会依托于大医院，以减轻大医院养老康复的压力
高端医疗服务	建立高端医疗机构，在服务、环境、定价体系方面区别于普通医疗机构	服务质量 医疗水平 政策导向	高端医疗机构的数目增多，增长速度并不会特别快，各机构比拼的是服务质量以及专业水平

数据来源：NMPA，爱尔眼科公告，三星医疗公告，长江证券研究所

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

03

子行业投资框架

汇聚财智　共享成长

Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth

03 子行业1/6：原料药

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

		关键驱动因素	分析着眼点	未来发展趋势
原料药	大宗原料药	生产规模； 成本控制； 产品价格；	**产能集中度情况**，垄断定价； **主导产品的价格，**把握波动趋势； **成本与规模控制** **产品供需情况**：一般情况下比较稳定；	产能过剩的情况没有改变，**企业重组或者联合或重组**。 企业生产方向逐步从**大宗原料药向特色原料药转变**
			原料药企业资本支出一般较大，要注意资产结构和财务结构方面的分析	
	特色原料药	品牌建设 渠道控制	**产品梯队建设**，前瞻性的产品储备可以增强发展的持续性； **研发和技术进步**； **海外的品牌影响力**； **海外的药政注册**，EHS等各种体系的认证；	

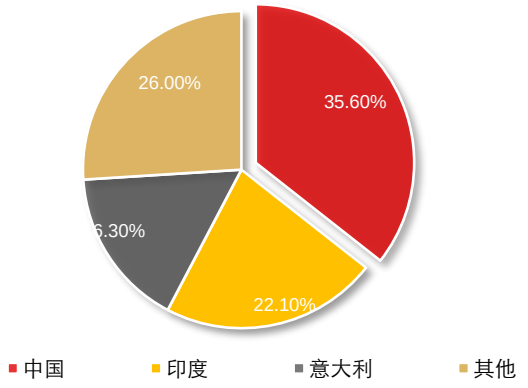
数据来源：九洲药业公告，天宇股份公告，长江证券研究所

03 子行业1/6：原料药

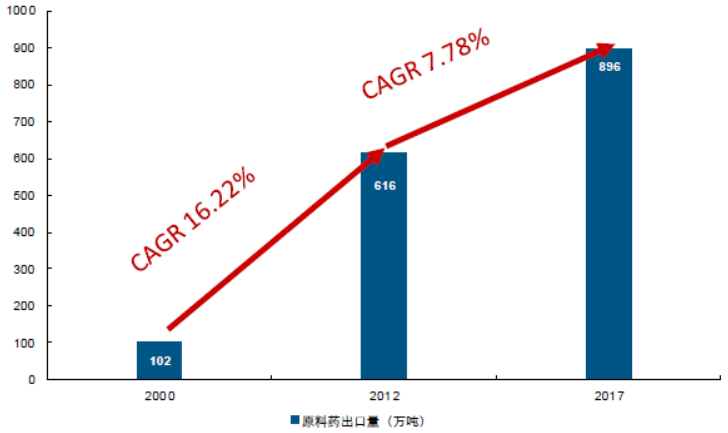
长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

中国是世界第一原料药生产国。可生产的原料药将近1500种。规模超过300亿美金。

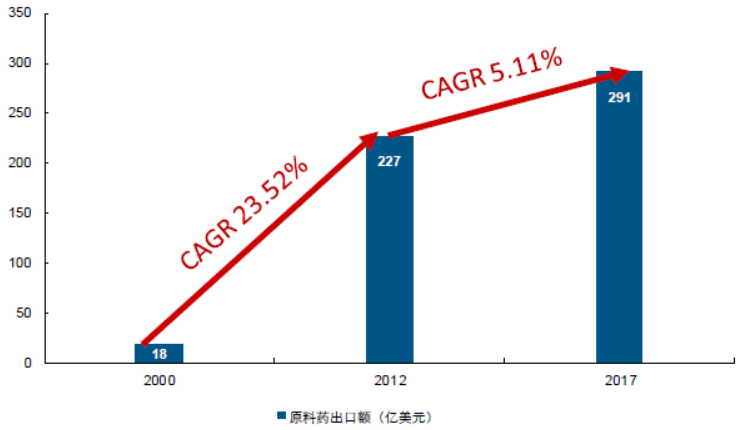
图：全球原料药市场格局



图：我国原料药出口量



图：我国原料药出口额



数据来源：九洲药业招股书，海关局，长江证券研究所

03 子行业2/6：化学制剂

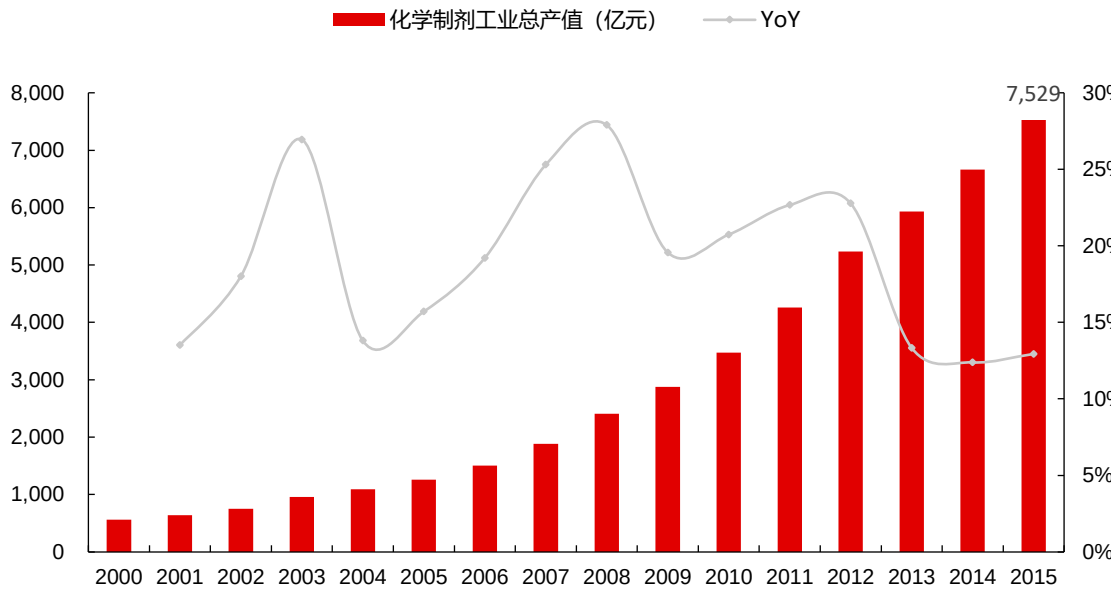
长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

		关键驱动因素	分析着眼点	未来发展趋势
化学制剂	处方药 恒瑞医药、丽珠集团 华海药业、信立泰 恩华药业（优质仿制药企及创新药企）	主导产品竞争力； 研发能力； 销售渠道情况	主导产品所处疾病领域及治疗学优势（临床终端使用偏好）； 主导产品的商业价值（文号、医保、招标、中标价）； 研发能力、产品梯队建设、平台型创新； 不同疾病领域的销售渠道控制； 整体战略：求新（研发创新），求变（体制之变，转型及新业务）	行业进入平稳增长阶段；控费、提高质量、鼓励创新等改革措施持续利好优质仿制药及创新药企业； 改制、转型、布局新业务
	非处方药 华润三九等 （传统品牌品种+重磅新品）	终端渠道建设； 品牌建设	终端渠道建设能力； 品牌建设（广告费用率及终端维护费用为主要费用支出项目）； 线上与线下销售渠道建设； 未来增量产品梯队建设	居民健康管理需求引导行业发展； 未来依赖线上与线下销售渠道同步构建

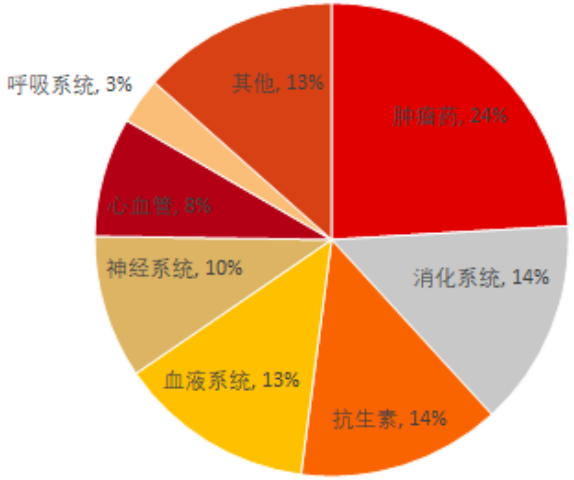
数据来源：IMS，Citi Research，BCG Analysis，长江证券研究所

03 子行业2/6：化学制剂

图：化学制剂行业增速及规模



图：化学制剂行业市场格局



数据来源：Wind，米内网，长江证券研究所

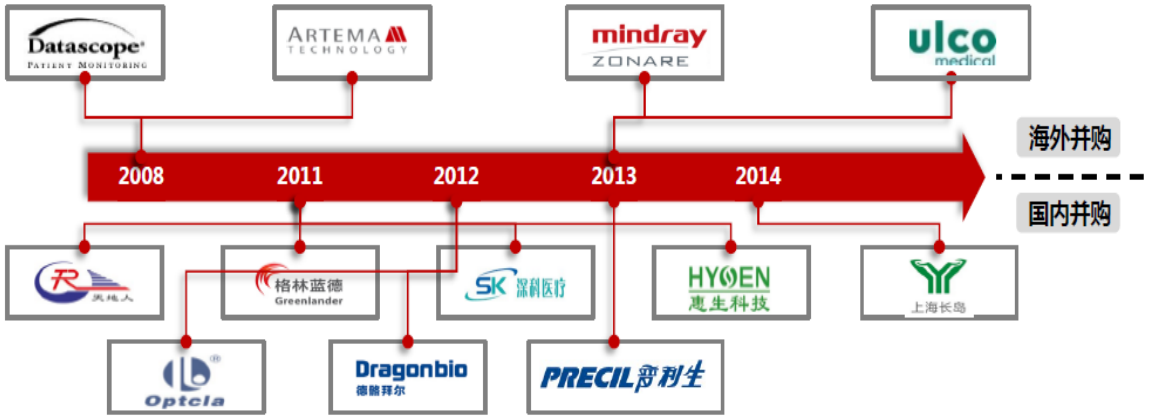
03 子行业3/6：医疗器械

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

增长驱动力	产品	平台化&横向发展：并购、新业务布局	乐普医疗、迈瑞医疗
		纵向发展：自主、JV、引进团队、科研合作	迈瑞医疗、威高股份
	市场	海外市场	迈瑞医疗
		进口替代领域	乐普医疗、上海联影
		低端产品市场	国内低端企业

平台化&横向发展：美敦力、强生、西门子、迈瑞医疗等。

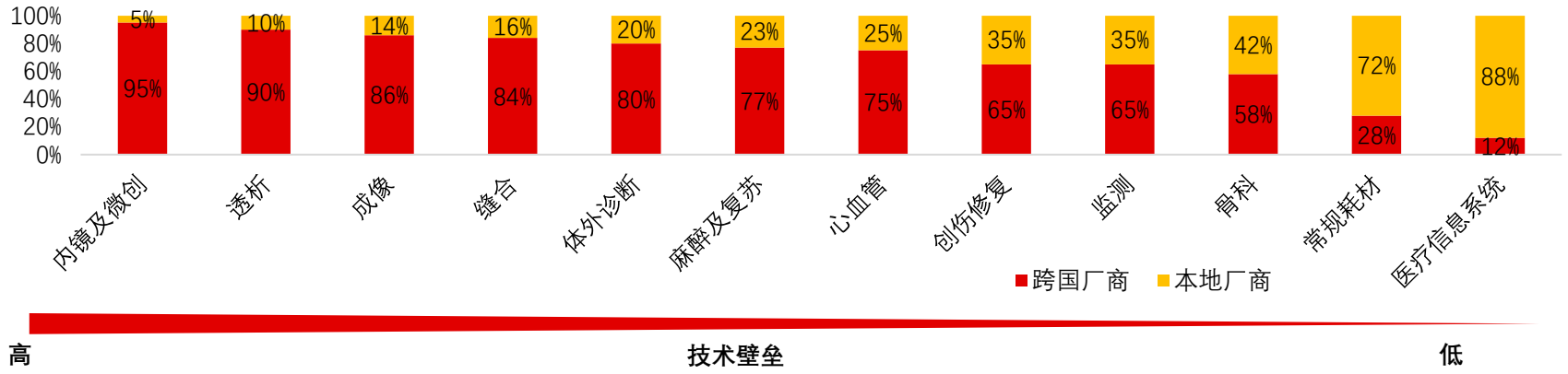
迈瑞的拓展：2001年超声；2003年生化；2006年麻醉机；2009年除颤仪、灯床塔；2011年呼吸机、输注泵；2013年化学发光；2017年硬式内窥镜。



数据来源：BCG Analysis，迈瑞医疗招股书，长江证券研究所

03 子行业3/6：医疗器械

	关键驱动因素	分析着眼点	未来发展趋势
植入性器械	核心技术壁垒	技术创新，进口替代	持续创新能力型企业将成为主导
大中医疗设备	核心技术壁垒	政策因素，进口替代	国产龙头将受益下一阶段配置政策
家用医疗器械	整体布局及渠道	龙头企业战略及优势	健康管理、远程医疗、医疗物联网
常规医疗耗材	国外/国内渠道	渠道与规模效应	行业集中度将提升
医院基建设备	技术，医疗服务	与医疗服务的协同	本土企业主导，随医疗服务版块增长



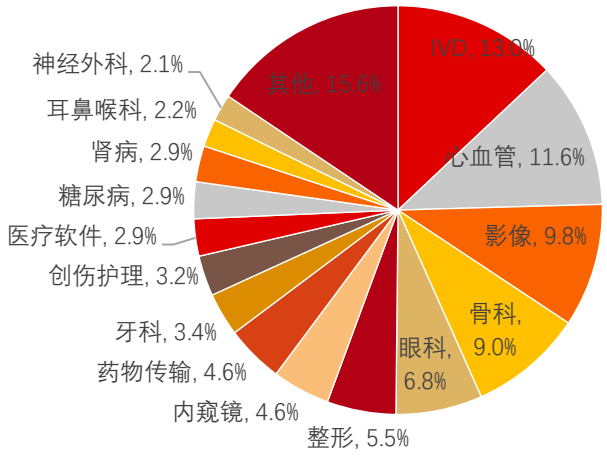
数据来源：BCG Analysis，中国医疗器械蓝皮书，长江证券研究所

03 子行业3/6：医疗器械

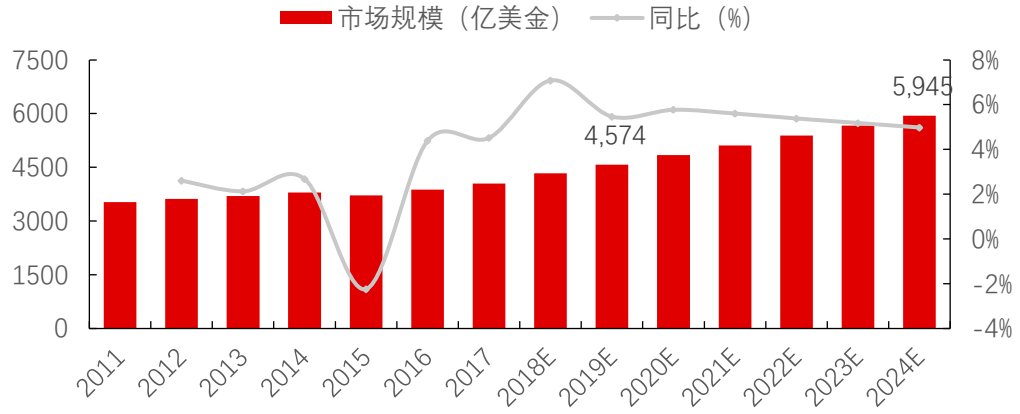
行业成长确定。近十年CAGR达到20.5%，中国医疗器械市场规模占比低，远低于欧美及全球均值，未来发展潜力巨大。

国内药械比提升空间大。从药品和医疗器械人均消费额比例（药械比）的维度，中国的药械比大概是1:0.351，发达国家1:0.981，器械占比较低。

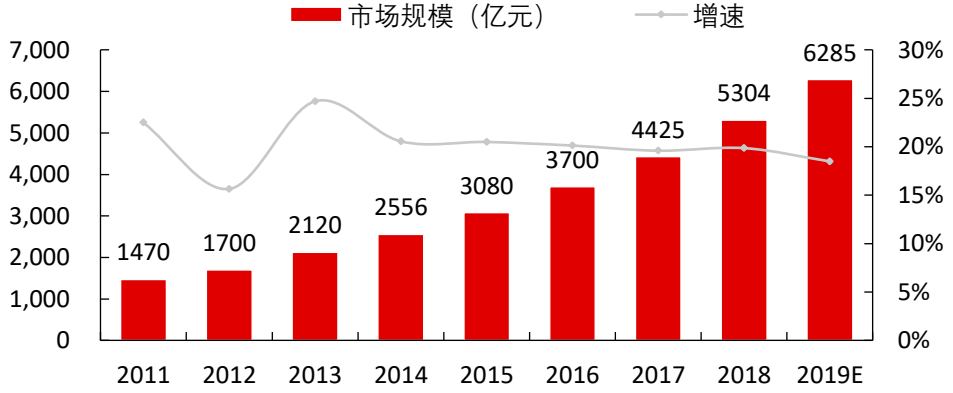
图：2019年全球医疗器械市场分布



图：全球医疗器械市场规模和增速情况



图：中国医疗器械市场规模和增速情况



数据来源：Evaluate Tech，医疗器械蓝皮书，长江证券研究所

03 子行业4/6：中药

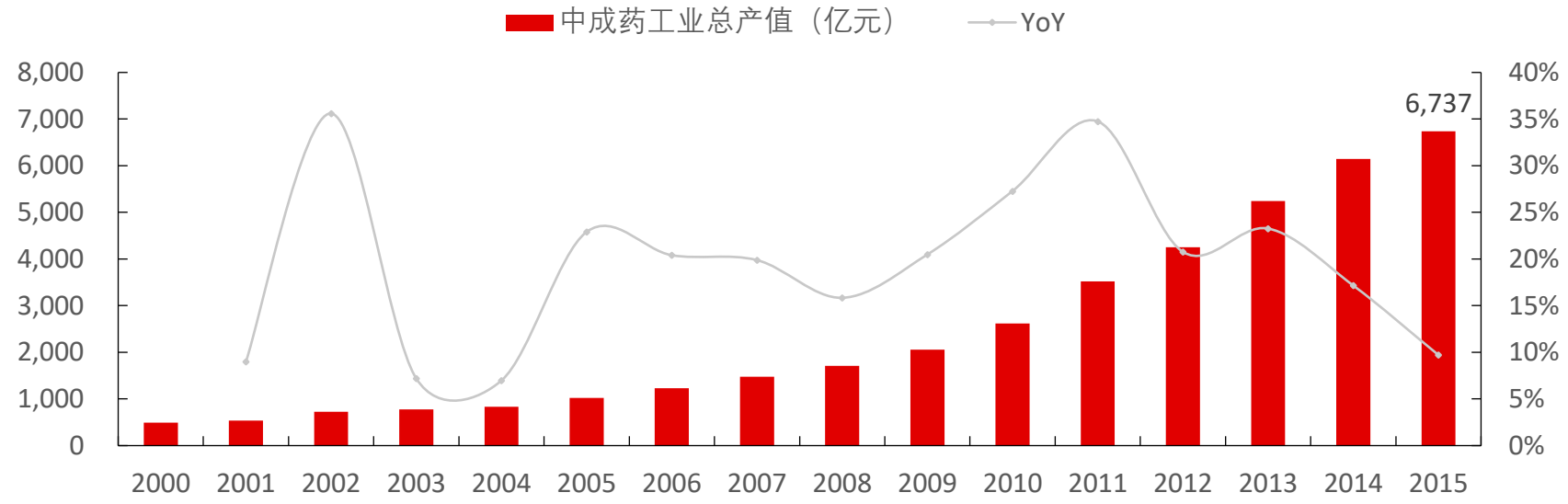
		关键驱动因素	分析着眼点	未来趋势
中成药	品牌中成药	品牌影响力；产品垄断性	**产品定价能力**：产品的独占性和垄断定价能力； **原材料资源控制力**：原材料有无受到限制，存货控制（中成药企业为了生产需要，会提前储备大量的中药材）； **营销管理**：围绕现有产品群的市场开发能力	**收入增速下降：**控制药占比和辅助药，注射剂增速下降多重负面因素 **向药用消费品领域延伸**：抵御原材料涨价压力。
中成药	现代化中药	研发水平；营销能力	**研发能力**，现代化中药主要是产品创新和剂型创新为主，安全性要求高，对企业的研发能力是挑战； **产品梯队建设**，建设多元化的平衡型产品梯队对稳定持续发展有积极意义； **营销把握**：现代化中药需要专业型的销售体系和团队	**收入增速下降：**控制药占比和辅助药，注射剂增速下降多重负面因素
中药饮片		质量标准；渠道控制	饮片质量标准； 渠道控制：饮片企业对上游采购和下游中医院的渠道有一定要求；同时物流配送要求高； 延伸产业链	**行业整合：**行业在政策推动下整合有望提速；饮片不纳入“药占比”控制，政策对于饮片在价格层面相对宽松

数据来源：片仔癀公告，以岭药业公告，长江证券研究所

03 子行业4/6：中药

中药在国家医保整体控费趋势下，承压较大。1）中药注射剂的销售空间被快速压缩；2）中成药针对治疗效果差，无法满足医疗机构需求；3）国家医保广覆盖，但严控费。

图：国内中成药行业规模及增速（2000-2015年）



数据来源：Wind，长江证券研究所

03 子行业5/6：医药流通

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

		关键驱动因素	分析着眼点	未来趋势
药品流通	药品批发	地域性发展； 规模效应； 专业性	**地域**，地区经济发展不同区域环境不同； **规模效应**：建立在规模效益之上的低成本优势； **资金周转指标**（应收回款期、存货周转率）：回款压力如何； **营销管理**：围绕产品群的市场开发能力； **订单量、专业性：**批发企业向上游采购时是否较强的议价权； **成本控制**（能否有效控制期间费用率）；	低利率背景下有利于企业控制财务费用； 批发行业集中度不断提高
	药品零售	地域性发展； 规模效应； 创新能力； 营销能力	**地域**，地区经济发展不同区域环境不同； **连锁经营，**是否连锁及连锁店数量； **资金周转指标**（应收回款期、存货周转率）：回款压力如何 **成本控制**（能否有效控制期间费用率）； **营销能力**：专业型的销售体系和团队 **产业链延伸**	低利率背景下有利于企业控制财务费用； 集中度及连锁化空间大； 分级诊疗、医药分家等政策推进下，销售终端由城市医院向零售药店及网上药店分流

数据来源：Wind，中国医药公告，上海医药公告，长江证券研究所

03 子行业6/6：医疗服务

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

医疗服务

- 诊断
- 治疗
- 防疫
- 生育
- 健康管理

关键驱动因素

1.产业资源调整，中心下移
2.政策助力，充分利用基层医疗资源
3.服务提价，实现以医养医提升医疗服务在医院总收入的比重
4.引入社会资本，发展多元化产权结构

分析着眼点

1.关注基础医疗服务中的产业升级和技术的进步
2.医院或者企业积极转型，转型的结构与需求是否适应政策变化，政策利好不断，相关企业受益
3.新模式的转变，是否有成熟稳定的模式，如专科连锁社会资本的介入对公立医院的冲击。
4.民营医院的服务质量
5.在细分领域中是否具有长期盈利的能力

未来发展趋势

不管从**政策层面**还是**社会需求层面**，医疗服务行业都将会迎来高速发展的契机。

在发展方向上，更看好在**养老、康复等方向布局**的企业

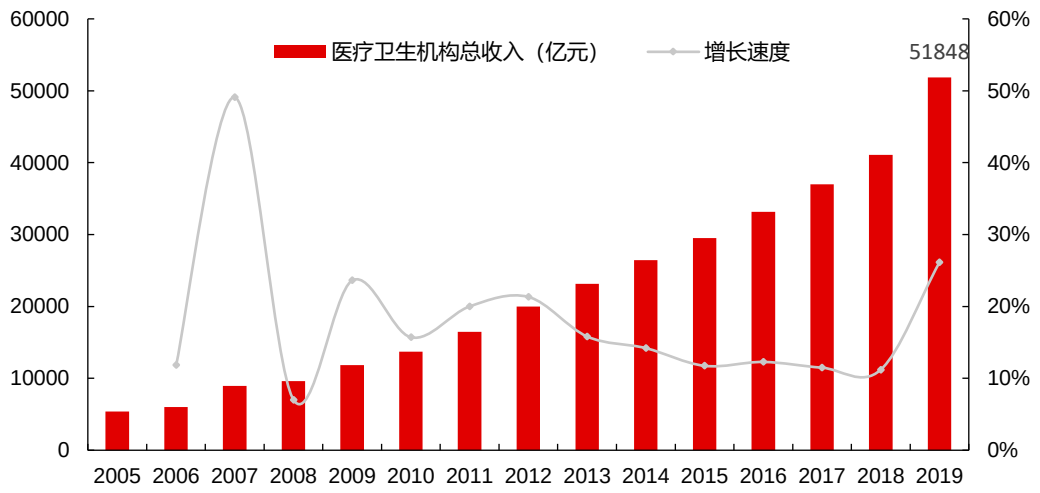
数据来源：Wind，锦欣生殖公告，长江证券研究所

03 子行业6/6：医疗服务

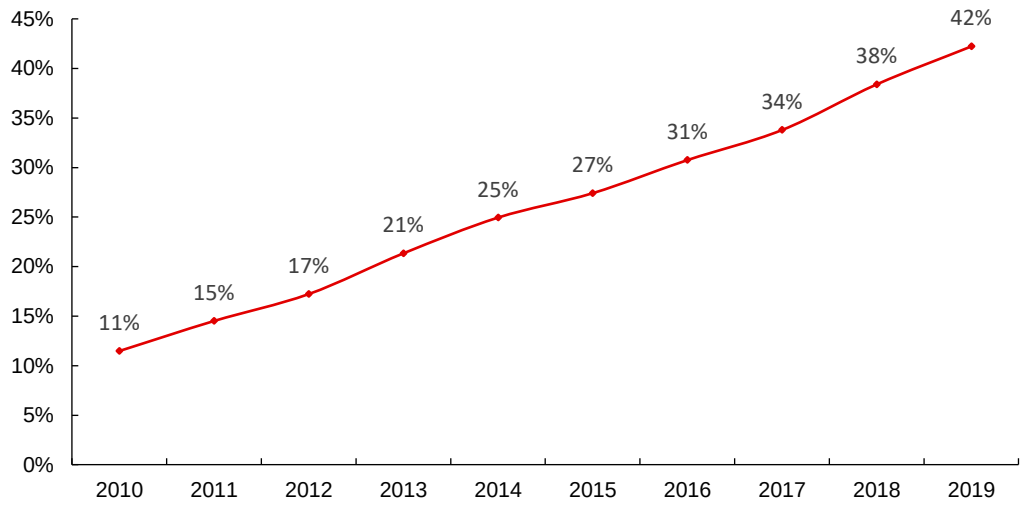
我国医疗服务行业兼刚性需求和消费性需求，中国医疗服务市场规模巨大，并且在人口老龄化、城镇化、财富增长以及基本医疗保障制度等因素的驱动下迅速扩容。

2019年我国卫生消费总额5.2万亿元，在过去10年保持了16%的复合增长率。

图：2010-2019医疗卫生机构总收入及增长速度



图：民营医院数量占比

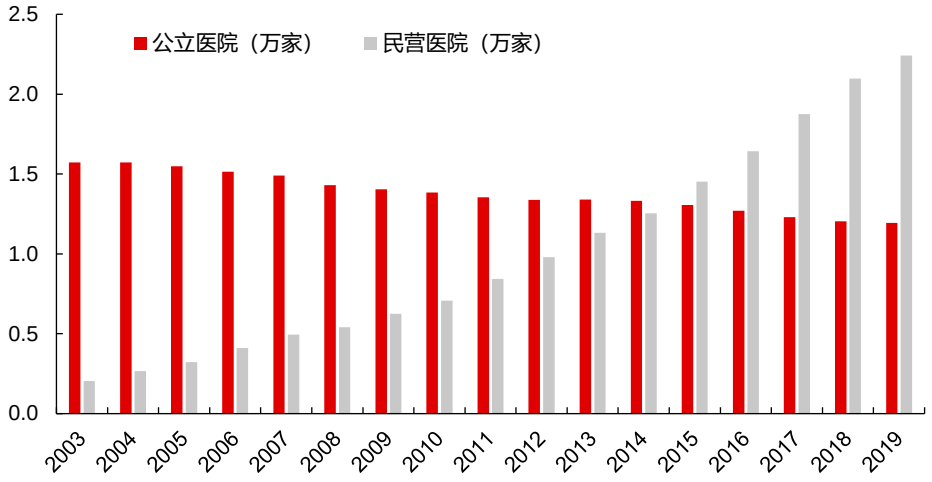


数据来源：中国卫生和计划生育统计年鉴，长江证券研究所

03 子行业6/6：医疗服务

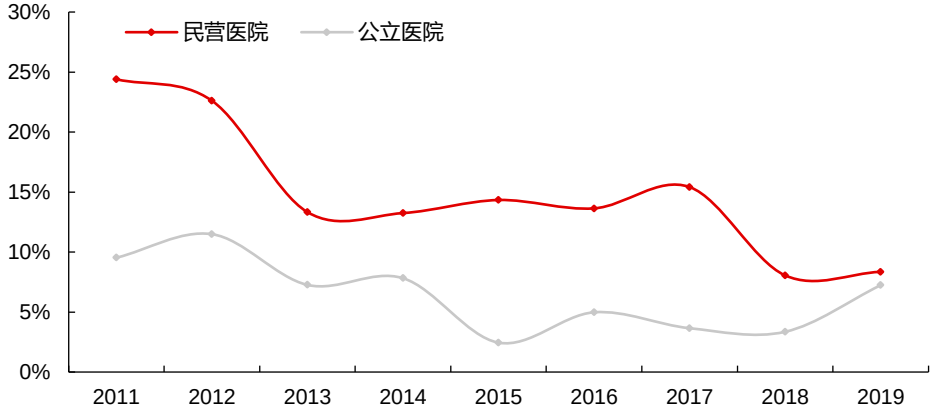
近年来，国家鼓励社会资本办医、鼓励执业医师多点执业、医保定点单位资格认证等政策频出，民营医院发展迅速，在数量上已经超过了公立医院；且民营医院诊疗人次增速始终明显高于公立医院。

图：国内民营医院数量高于公立医院



数据来源：Wind, 长江证券研究所

图：民营医院诊疗人次增速高于公立医院



数据来源：Wind, 长江证券研究所

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

04

从龙头成长看行业变革

汇聚财智　共享成长

Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth

04 恒瑞医药：底蕴深厚的创新药龙头

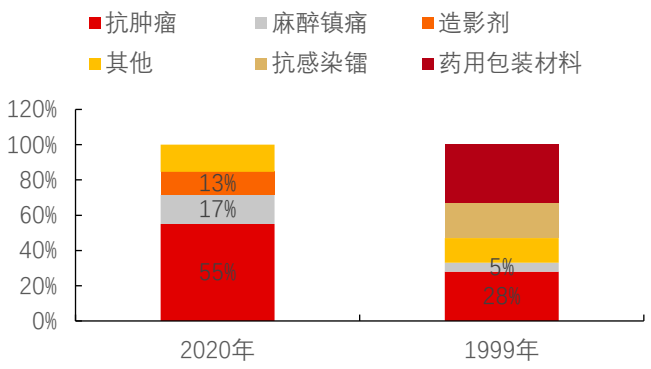
公司依靠内生实现了非常稳健的增长

- 2001-2020年，公司营收和扣非净利润CAGR分别为22%和27%；
- 仅个别年份同比增速低于5%；

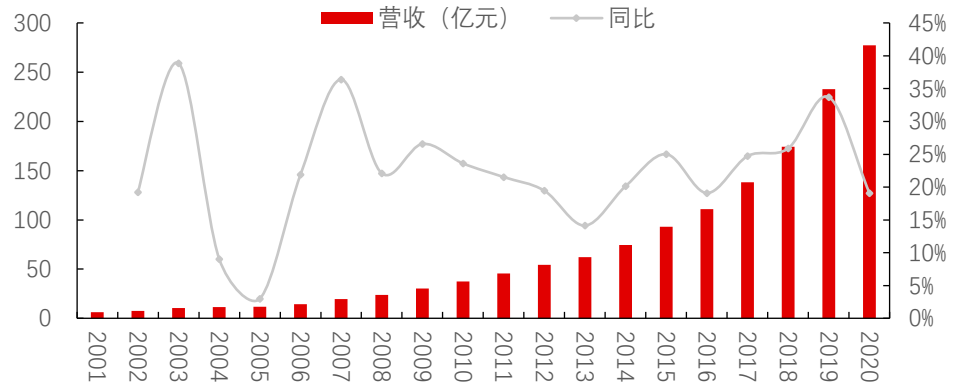
□ 产品结构不断优化（仿制药-首仿-创新药）

- 深耕起家的肿瘤和手术麻醉领域，20年合计营收占比72%；
- 站稳脚跟后持续投入创新药研发（2003年）

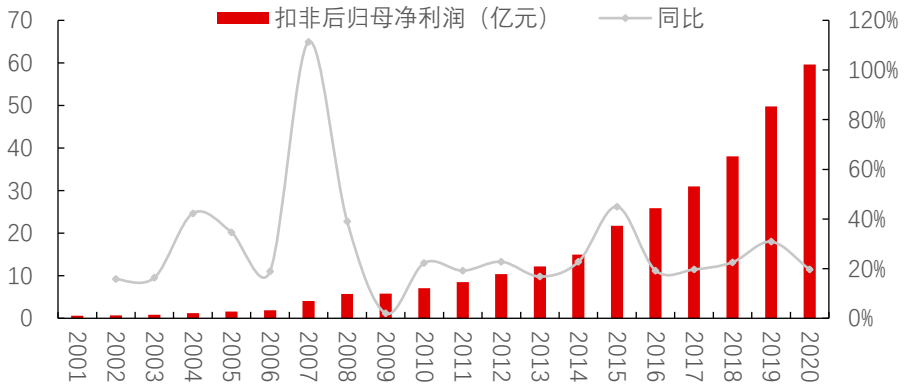
图：公司营收各细分领域分布情况



图：恒瑞医药上市以来营收增长情况



图：恒瑞医药上市以来净利润增长情况



数据来源：Wind，长江证券研究所

04 恒瑞医药：底蕴深厚的创新药龙头

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

战略延展性非常强，创新驱动发展

- 三大战略目标：制剂出口、创新药国内上市、创新药国外上市。前两个已经实现；
- 成长路径：抗肿瘤、麻醉和造影仿制品种立足（2000-2010年）；阿帕替尼、吡咯替尼和PD-1单抗等创新药上市成为新增长点。

表：恒瑞医药成长路径

年份	事项	影响	代表产品	结果
2000	抗肿瘤药大品种抢仿策略	第一轮高速增长	奥沙利铂、多西他赛、伊立替康、来曲唑等	2003年整体销售突破10亿元
2003	申报首个创新药	率先开启创新战略	艾瑞昔布	奠定了长期领先的管线基础
2004	麻醉药产品上市	第二轮高速增长	七氟烷、苯磺顺阿曲库铵等	2008年整体销售突破20亿元
2006	造影剂产品上市		碘佛醇、碘克沙醇等	2011年整体销售突破40亿元
2011	首个创新药&海外制剂获批	创新药进入收获期	艾瑞昔布、伊立替康	
2014	首个重磅创新药品种获批上市	第三轮高速增长	阿帕替尼	抗肿瘤药重回高增长
2015	首个创新药海外授权	开启创新药国际化	PD-1	市值首次突破1000亿元
2018	重磅创新药集中获批	第四轮高速增长	吡咯替尼、19K、白蛋白紫杉醇等	市值首次突破3000亿元
2019	超重磅创新药获批		卡瑞利珠单抗（SHR-1210）	市值首次突破4000亿元
2020	重磅创新药进入医保	第五轮高速增长	卡瑞利珠单抗（SHR-1210）	市值首次突破5000亿元

数据来源：Wind，恒瑞医药公告，长江证券研究所

04 恒瑞医药：培育出“研发+营销”两大核心竞争力

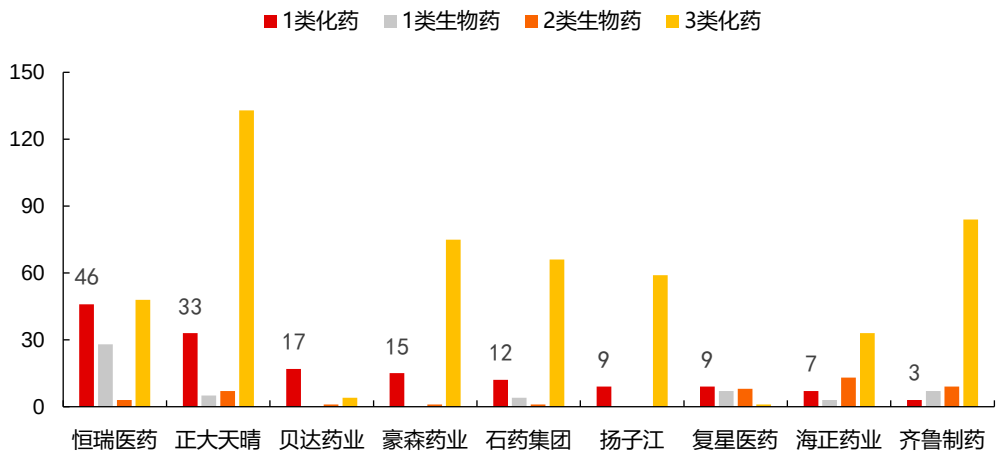
创新药研发形成闭环，投入强度大

- 以阿帕替尼作为标志性产品，经历过创新药“立项-研发-上市-销售”完整周期；
- 2020年，公司投入研发费用49.9亿元，营收占比达到18%，接近全球MNC平均值19%；

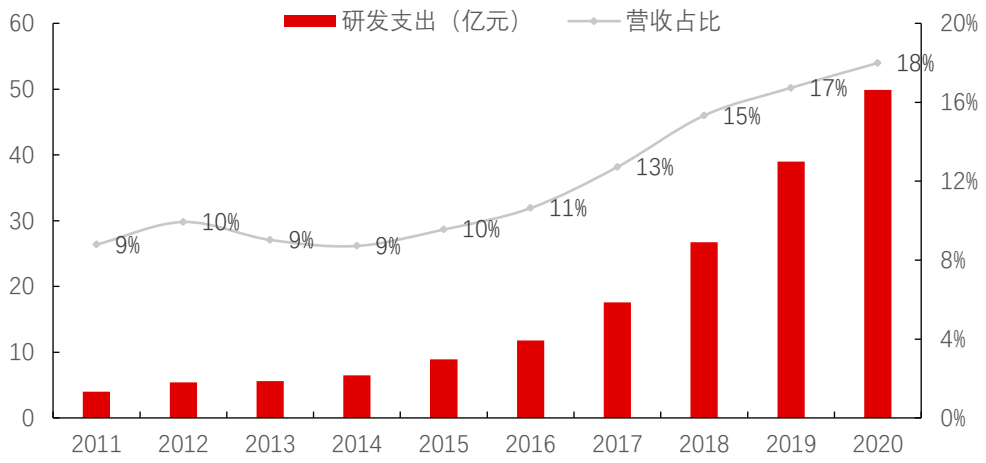
创新药IND大幅领先于国内其他企业

- 2014-2020，公司累计申报74个1类创新药，远高于中国生物制药（38个）、石药集团等企业（16个）；

图：国内研发型药企申报数量对比（2014-2020）



图：研发支出营收占比已经达到17%



资料来源：Wind，CDE，Citi Research，长江证券研究所

04 恒瑞医药：底蕴深厚的创新药龙头

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

肿瘤、麻醉和造影领域市占率第一，综合线有待验证

公司已经建立了超万人的学术推广队伍，在原有市场经验基础上不断创新思路，建立分线销售队伍，加强市场营销深度和广度；

麻醉和造影市占率大幅领先；肿瘤领域2018年样本医院市占率（8.40%）与阿斯利康（8.44%）相当。

表：恒瑞医药非独家品种销售情况

药品名称	样本医院销售排名	国内销售企业数量	恒瑞销售额（亿元）	样本医院市占率	2018样本医院销售额（亿元）
多西他赛	1	15	6.67	48.38%	13.79
右美托咪啶	1	6	7.01	81.13%	8.64
七氟烷	1	7	3.77	57.11%	6.61
苯磺顺阿曲库铵	1	5	5.32	71.61%	7.43
碘佛醇	1	4	4.37	93.87%	4.65
奥沙利铂	2	13	2.25	20.38%	11.05
碘克沙醇	1	6	6.24	58.92%	10.59
盐酸伊立替康	1	5	3.85	66.88%	5.75
来曲唑	2	3	1.60	30.92%	5.16
替吉奥胶囊	2	5	2.15	16.64%	12.95
克拉霉素缓释片	2	16	0.70	25.05%	2.78
卡培他滨	3	4	1.14	11.52%	9.88
盐酸托烷司琼	8	13	0.20	3.43%	5.92
唑来膦酸	3	13	0.32	5.78%	5.55
厄贝沙坦	4	13	0.14	3.81%	3.80
亚叶酸钙	1	16	0.26	65.12%	0.40

数据来源：Wind，米内网，长江证券研究所

风险提示

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

风险提示

- 宏观经济环境变化会对医药行业供需造成影响；
- 医药政策变化会对相关医药领域造成重大影响；

分析师声明、评级说明及重要声明

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

评级说明

行业评级	报告发布日后的12个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：	
	看　好：	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
	中　性：	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
	看　淡：	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的12个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：	
	买　入：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于10%
	增　持：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%～10%之间
	中　性：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%～5%之间
	减　持：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
	无投资评级：	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

THANKS 感谢倾听

Changjiang
Securities

汇聚财智 共享成长

Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth